



拔毛障碍（拔毛癖）

作者：[Katharine Anne Phillips](#), MD, Weill Cornell Medical College;

[Dan J. Stein](#), MD, PhD, University of Cape Town

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 11月 2025 | 修改的 1月 2026

拔毛癖是指患者反复拔除自己的毛发，导致毛发减少。

- 拔毛癖患者在拔头发前可能会感到紧张或焦虑，拔头发可能会缓解这种感觉。
- 症状的严重程度通常不固定，但可持续终生。
- 如果患者拔除过多的毛发进而导致毛发减少、尝试减少或停止拔毛但却做不到，并因其行为而感到非常痛苦或功能受损时，医生可诊断该疾病。
- 专门针对拔毛癖的认知行为治疗（习惯逆转治疗）、某些抗抑郁药或其他药物可能有助于控制症状。

此病患者强迫性地拔除或揪除自己的毛发，但并非出于美容原因。也就是说，他们拔毛不是为了改善外观。他们通常拉扯头皮、眼眉和/或眼睑上的毛发，但也可以是任何其他部位的毛发。

拔毛癖通常在青春期前后开始发病。约有 1-2% 的人患有拔毛癖。在成人中，拔毛癖在女性中更常见。

拔毛癖的症状

拔毛量和拔毛位置因人而异。有些拔毛癖患者有完全秃头的区域。眼睫毛和/或眉毛可能被全部拔光。而有些人的毛发部位则仅仅变稀疏。患者可能会随着时间改变其拔毛部位。

有些人可能是不由自主地去拔毛发，没有去想。有些则更为有意识地去拔。

拔毛癖患者并非因为担忧自己的外表，试图修复（就像[躯体变形障碍](#)症患者那样）而去拔毛。但是，他们在拔毛之前可能有紧张或焦虑感，而拔毛可以缓解他们的情绪。之后，他们可能会有一种满足感。

拔毛可能会伴随很多其他活动（仪式）。患者可能会煞费苦心地寻找要拔除的特定毛发。他们可能会在手指之间卷绕头发，在牙齿之间拉扯发缕，或用牙咬拔下的毛发。很多患者会吞掉毛发。吞下的毛发可能卡在胃部或消化道其他部位而形成肿块。这些肿块称为[毛石](#)，可能会使患者进食后早饱或导致恶心、呕吐、疼痛和其他消化道症状。

很多拔毛癖患者还会反复抓搔皮肤、咬指甲、咀嚼面颊或做其他重复性的身体关注性动作。他们也可能有抑郁。

患者可能会对其外表或无法控制行为的情况感到难为情或羞惭。他们可能会通过戴假发或围巾掩饰毛发的减少。有些患者从多个不同区域拔除毛发，以掩盖毛发的减少。患者可能会躲避其他人能够看到自己毛发减少的情形。他们通常不在外人面前拔扯毛发，家人除外。他们也可能因自己的失控而感到痛苦，并反复尝试停止或减少拔毛，但却无法做到。如果被问及，拔毛癖患者通常会承认他们的毛发减少是由于拔毛造成的。

有些患者是拔扯其他人或宠物的毛发，或抽拉衣物、毛毯或其他纺织品的丝线。

拔毛障碍（拔毛癖）

图片

在拔毛障碍（拔毛癖）中，患者会反复地拔掉毛发。患者可能有一处或多处斑片状脱发，毛发长度不同，通常呈不对称或不规则模式。拔毛障碍患者可能会试图掩盖毛发减少情况。

© SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA

拔毛癖的诊断

- 医生根据特定精神病诊断标准进行评估
- 体格检查，有时需要进行医学检查，以评估躯体疾病

医生根据以下症状诊断拔毛癖：

- 过度拔除毛发，导致毛发减少（可能不易察觉）
- 反复尝试减少或停止拔毛
- 对自己的行为感到极大的痛苦或社会功能受到损害

要诊断拔毛癖，拔毛行为应不能用一般医学疾病或其他精神疾病（如躯体变形障碍）更好地解释。

拔毛癖的治疗

- 认知行为疗法（习惯逆转治疗）
- 药物

专门针对拔毛癖的认知行为疗法是首选的初始疗法。最常使用的认知行为治疗是习惯消除治疗。这种治疗会教患者做以下事情：

- 更加意识到自己在做什么
- 识别触发拔毛的情境
- 使用策略帮助他们阻止自己拔毛——例如，从拔毛改为不同的活动（例如握紧拳头、编织或坐在自己手上）

有些医生使用药物帮助患者控制症状。通常首先尝试 N-乙酰半胱氨酸 (NAC) 或美金刚；它们可能会减少拔毛行为。选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 或氯米帕明（一种[也作用于血清素的抗抑郁药](#)）也可能对此病有效，尤其是患者伴有[抑郁](#)或[焦虑](#)症状的情况下。